혈압약, 먹었다 말았다 하면 안 되는 이유

혈압약은 정해진 시간에 **매일** 먹는 약입니다. 목표는 수치뿐 아니라 **변동을 줄이는 것**이며, 며칠 괜찮았다고 스스로 거르거나 끊으면 도수 맞는 **안경을 벗는 것**과 같습니다.

먼저, 이 세 가지를 기억하세요 (Key Numbers)

1차 목표 · 가정혈압	체중 1KG 감량 시	약 조절 판단 기준
135/85	**약 1**	**여러 날**
mmHg 아래 (개인별 목표는 진료에서 결정)	mmHg 안팎 하강 (수축기, 평균)	평균 — 하루 수치 하나가 아님

두 가지 목표 — 수치, 그리고 변동 (Two Goals)

구분	핵심 기준	설명 및 중요 이유
1차 목표 · 수치	가정혈압 **135/85mmHg 아래**를 기준으로 봅니다.	동반 질환에 따라 **개인별 목표는 진료에서** 따로 정합니다.
2차 목표 · 변동을 줄이는 것	약을 **먹었다 말았다** 하면 혈압의 오르내림이 커집니다.	진료 때마다 혈압이 크게 흔들리는 사람일수록 **뇌졸중·심장병 위험이 높다**는 연구들이 있습니다.

가정혈압을 기록하는 방법 검증된 위팔 혈압계로 아침 기상 후 1시간 이내 배뇨 후 식사·복약 전, 저녁 취침 전에 잽니다. 앉아서 5분 이상 쉰 뒤 1~2분 간격으로 2회 측정해 모두 기록합니다. 외래 전 5~7일 기록에서 첫날을 제외한 평균을 봅니다.
아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

며칠 괜찮았다고 판단하지 마세요



규칙적으로 먹어야 하는 이유 · WHY DAILY	
약효 주기	**1. 하루 안 먹었는데 괜찮았다는 건 근거가 안 됩니다** — 약효가 자리 잡고 빠지는 데는 며칠에서 몇 주가 걸립니다.
안경 비유	**2. 약을 먹어서 정상인 건 약이 잘 맞는다는 뜻** — 도수 맞는 안경처럼, 잘 보인다고 벗지 않듯 계속 유지합니다.
체중·계절	**3. 체중이 빠지면 혈압도 내려갑니다**(1kg에 약 1mmHg 안팎). 여름엔 낮고 겨울엔 오르는 경향도 있지만, 계절이나 체중만으로 스스로 약을 조절하지는 않습니다.

흔한 오해 vs 올바른 접근 (Common Myths)

자주 듣는 오해 · MYTH	근거 있는 접근 · FACT
1. "아침 혈압이 좋으면 그날은 안 먹어도 된다"	**1. 아침 수치 하나로 그날 약을 거르지 않습니다** — 정해진 시간에 매일 먹습니다
2. "수치가 좋아지면 끊어도 된다"	**2. 좋은 수치는 약이 잘 맞고 있다는 신호** — 스스로 끊지 않고 진료에서 상의합니다
3. "안정되면 이틀에 한 번만 먹어도 된다"	**3. 줄여야 할 때도 격일이 아닌 약한 용량으로 매일** — 판단은 여러 날 평균으로 상의합니다
4. "나이 들면 130~140은 괜찮다"	**4. 나이만으로 목표를 정하지 않습니다** — 개인 목표는 진료에서 정합니다

감량도 진료 계획에 따라 증상성 저혈압·체중 감소·낮은 가정혈압과 심장·콩팥 보호 목적을 함께 평가합니다. 한 번 높다고 혈압약을 필요 먹지 않습니다. 중단을 결정한 경우에도 2주·4주, 이후 매달 혈압을 확인합니다.
아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 208, 4층 · ☎ 031-992-4560
평일 08:30 – 18:30 · 토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/htn-why-start/

근거: 2022 대한고혈압학회(KSH) 고혈압 진료지침 · 방문 간 혈압 변동성 메타분석(Eur J Prev Cardiol 2026 · Eur Heart J 2025) · 체중감량-혈압 메타분석(Hypertension 2003). 본 자료는 일반 안내이며 개인별 목표·용량은 담당의의 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/htn-daily-adherence/